Tratamiento farmacológico del dolor oncológico

Dolor crónico: dolor oncológico

tech

CONTENIDO

1. Objetivo

2. Introducción

3. Estrategia farmacológica

4. Paracetamol y AINE

5. Opioides

Rotación de los opioides

6. Adyuvantes

7. Tratamiento de tipos específicos de dolor

Dolor neuropático
Dolor en metástasis óseas
Dolor oncológico irruptivo

8. Conclusiones

9. Bibliografía

Objetivo

- Conocer el tratamiento farmacológico del dolor oncológico.
- Identificar el tratamiento para tipos específicos de dolor oncológico.

Introducción

Desde que se mantuvieron los primeros registros médicos, el cáncer como enfermedad se ha descrito en la historia de la medicina. Las primeras descripciones conocidas del cáncer aparecen en siete papiros, descubiertos y descifrados a finales del siglo XIX *(figura 1)* (1).

Proporcionaron el primer conocimiento directo de la práctica médica egipcia. Contienen descripciones sobre el cáncer escritas alrededor del 1600 a.C., y se cree que datan de fuentes tan tempranas como 2500 a.C. Tras el declive de Egipto, los siguientes capítulos de la historia médica y científica se escribieron en Grecia y Roma (1).

Los grandes médicos Hipócrates y Galeno dominaron el pensamiento médico durante 1.500 años *(figura 2)*. Sacaron la medicina de los reinos de la magia, la superstición y la religión. Hipócrates y Galeno definieron la enfermedad como un proceso natural y basaron el tratamiento en la observación y la experiencia. Se identificaron neoplasias, con advertencias contra el tratamiento de las formas más graves. A Hipócrates se le atribuye el nombre de "cáncer" como "karkinoma" (carcinoma) (1).

En el mundo moderno, la ciencia y la cirugía avanzaron a medida que los médicos volvían a la observación directa del cuerpo humano. Sin embargo, la teoría de que el cáncer fue causado por un exceso de bilis negra continuó prevaleciendo hasta el siglo XVI. La enfermedad se consideró incurable, aunque se formuló una amplia variedad de brebajes que contenían arsénico para tratar sus manifestaciones (1). En el siglo XVII, la vieja teoría de la enfermedad basada en humores corporales fue descartada cuando los vasos del sistema linfático fueron considerados como su principal causa (1).

En el siglo XVIII Bernard Peyrilhe realizó algunos experimentos para confirmar o refutar la hipótesis no anatómica relacionada con el cáncer. Sus esfuerzos, por absurdos que parezcan en retrospectiva, establecieron la oncología experimental; la ciencia de buscar mejores diagnósticos, tratamientos y comprensión de las causas de la enfermedad. Durante este período, se reportaron cánceres relacionados con exposición ambiental y se abrieron hospitales especializados en atención oncológica (1).

A fines del siglo XIX, el desarrollo de mejores microscopios no solo ayudó a documentar y definir los organismos que causaban las enfermedades, sino que también hizo posible el examen de las células y su actividad. El estudio de los tejidos y tumores reveló que las células neoplásicas tenían una apariencia diferente al tejido circundante normal *(figura 3)* (1).

El comienzo del siglo XX fue testigo de grandes avances en la comprensión de las estructuras, funciones y química de los organismos vivos. La investigación del cáncer en cultivos celulares, carcinógenos químicos, técnicas de diagnóstico, y quimioterapia estableció firmemente a la oncología como ciencia (1).

En 1911, se documentó una causa viral de cáncer en las gallinas y se identificaron de manera concluyente carcinógenos químicos y físicos. También se investigaron las anomalías cromosómicas como posibles causas de la enfermedad (1).

En los años sesenta y setenta, hallazgos impresionantes en torno a la genética transformaron la perspectiva diagnóstica y terapéutica, dando lugar a la medicina de precisión y la mejora de la supervivencia y calidad de vida *(figura 4)* (1).

Durante tres milenios, el cáncer se ha relacionado con la esencia del hombre, y esta es su esencia en la humanidad. Las posibles soluciones para la prevención y cura del cáncer parecen estar limitadas únicamente por la imaginación (1).

En la actualidad se denomina cáncer a un grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento excesivo y la propagación de células anormales. Si esta propagación no se controla, puede causar la muerte (2, 3). La mortalidad a causa del cáncer, es mayor en países en vías de desarrollo, donde el sistema no cuenta con los medios y materiales necesarios para combatirlo (2).

En las últimas décadas se ha incrementado el número de personas diagnosticadas y tratadas por cáncer, y se ha observado un cambio en la concepción de la enfermedad, ya no como enfermedad terminal, sino como una enfermedad crónica (2).

Figura 1. Papiros.

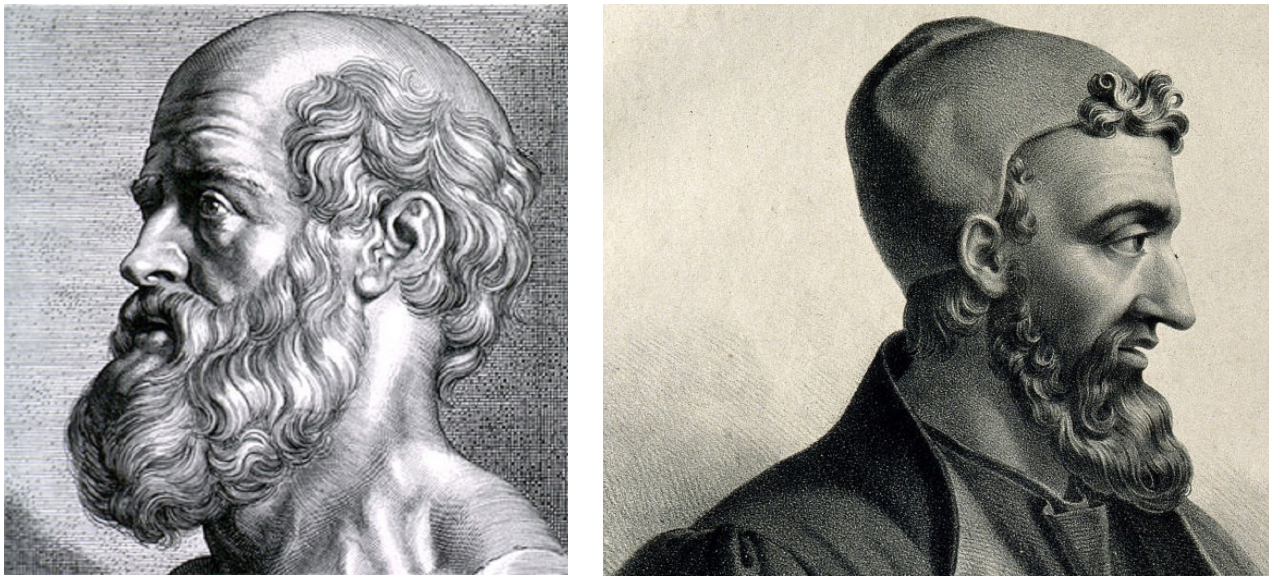

Figura 2. Hipocrates y Galeno.

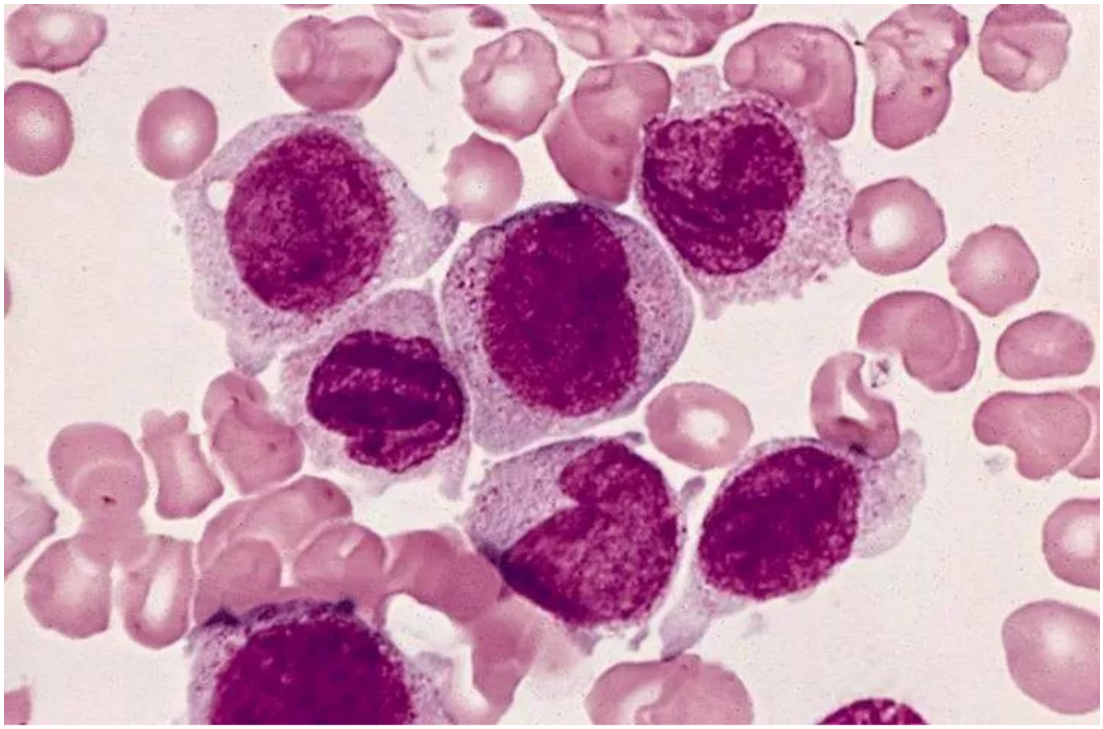

Figura 3. Células malignas vistas en microscopio óptico.

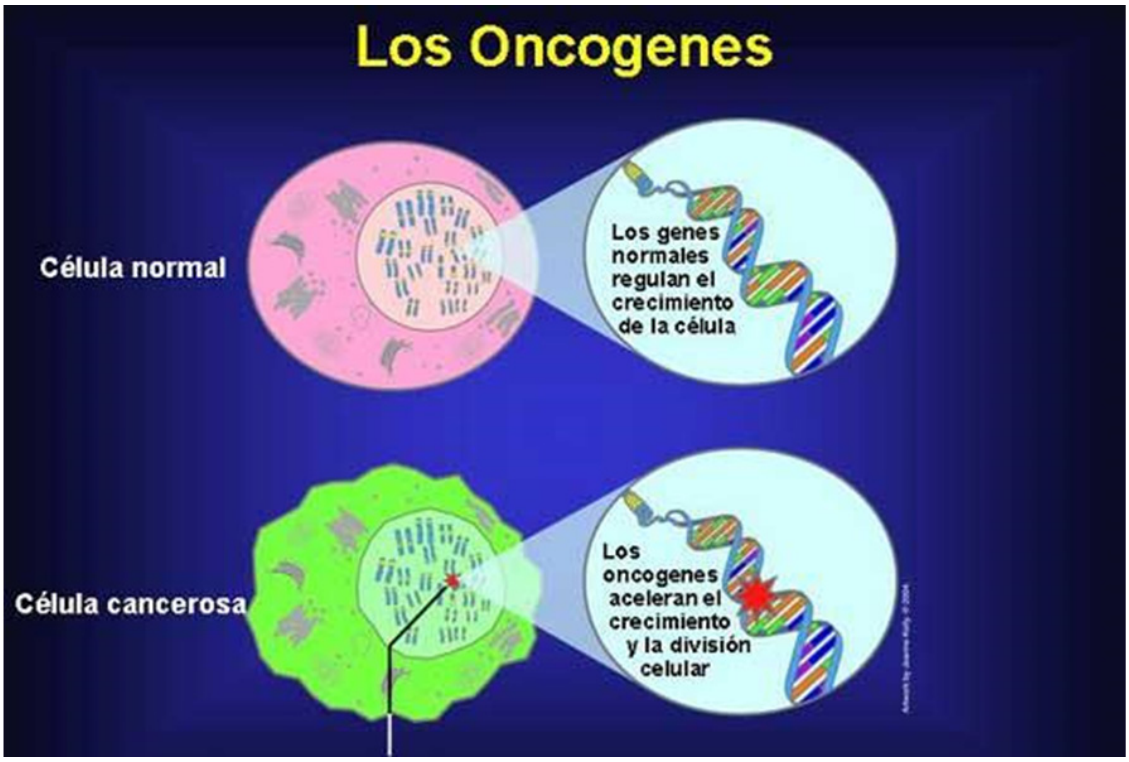

Figura 4. Oncogenética.

Es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio y la segunda causa de muerte en el mundo, después de las enfermedades cardiovasculares (4). El Observatorio Europeo del Cáncer (ECO-OEC) estima que la incidencia de cáncer presenta una tendencia en aumento; alcanzando cifras en 2018 de 683,5 casos por cada 100 000 habitantes y suponiendo la muerte de más de 294,3 por cada 100 000 pacientes (5).

Uno de los síntomas más frecuentes en el paciente oncológico es el dolor, con una prevalencia del 47 al 54 % según el tipo de tumor, localización, extensión y progresión de la enfermedad, alcanzando el 90 % en cáncer avanzado. Es un síntoma que perdura incluso una vez erradicada la enfermedad y supone una pérdida de la calidad de vida del paciente. Por eso, el manejo del dolor oncológico debe ser fundamental tanto durante, como después de la enfermedad (4).

Durante toda la historia natural del cáncer, alrededor del 50 % de los pacientes presentan dolor, alcanzando al 75 % en situación de enfermedad avanzada y terminal. Además, del total de estos enfermos, en torno a un 25 - 30 % presentarán un dolor de alta severidad, mientras que un 60 % sufrirá más de un tipo de dolor y un 30 % padecerá 3 o más tipos diferentes de dolor. Casi un 30 % de los enfermos oncológicos no reciben un tratamiento analgésico adecuado (5).

Según las estimaciones actuales, 5,7 millones de personas tienen acceso limitado a los analgésicos opioides en América Latina y el Caribe, con niveles moderados de consumo (1-10 mg de equivalente de morfina per cápita por año) en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Cuba, México, Costa Rica y Uruguay, Guatemala, Honduras y Bolivia; en los últimos tres, los niveles se han mantenido particularmente bajos, lo que indica que el consumo medio se encuentra muy por debajo de los rangos a escala internacional (2).

Ello sugiere que el manejo del dolor es inadecuado en gran parte de la población latinoamericana (2). Según las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Oncología Médica, las localizaciones anatómicas más frecuentes de dolor, señaladas por pacientes con cáncer, son: columna vertebral (36 %), abdomen (27 %), tórax (24 %), miembros inferiores (22 %), cabeza, cuello y región pélvica (17 %), miembros superiores (11 %) y región perianal (7 %) (2).

El dolor impacta en todos los aspectos de la vida de una persona, no sólo interfiriendo con su actividad, sino también con sus emociones, motivaciones, relaciones interpersonales y calidad de vida en general. Existe suficiente evidencia que demuestra la relación entre supervivencia y control del dolor; de allí la importancia de controlar el dolor a través de intervenciones efectivas (6).

Tradicionalmente, en el paciente con cáncer coexiste el dolor agudo y crónico. Se distinguen los siguientes tipos de dolores físicos (2, 4, 6):

- **Somático o nociceptivo:** por estimulación de nociceptores cutáneos y de tejidos profundos como el hueso. Es un dolor constante y bien localizado. Son ejemplos de este tipo de dolor las metástasis óseas y el dolor de las incisiones postquirúrgicas (2, 4, 6).
- **Visceral:** como resultante de la infiltración, compresión, distensión o estiramiento de vísceras torácicas y abdominales por afectación primaria o metastásica. Es un dolor mal localizado, y a menudo referido a la piel. Puede asociarse a síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, sudoración, sobre todo el dolor agudo (2, 4, 6).
- **Neuropático:** por afectación de los nervios periféricos, plexos o médula espinal, a causa de infiltración, compresión tumoral, o secundario a la quimioterapia, radioterapia o cirugía. Es un dolor paroxístico, quemante, eléctrico, sordo, urente o lancinante; acompañado de parestesias, disestesias, hipo e hiperestesia, así como de alteraciones motoras, sensitivas y del Sistema Nervioso Autónomo (2, 4, 6).
- **Mixto:** con características de dolor nociceptivo y neuropático, es el tipo de dolor más frecuente en los pacientes oncológicos (2, 4, 6).

La evaluación exhaustiva del dolor es esencial para asegurar un manejo adecuado, se debe realizar desde el momento del diagnóstico, con seguimiento a intervalos regulares y cuando se inicie un nuevo tratamiento (6).

En la medida de lo posible, la intensidad del dolor debe ser cuantificada por el paciente usando una escala numérica de 0 a 10, o una escala pictórica. La escala de dolor con caras *(figura 5)* puede ser útil en pacientes que presenten dificultades con otras escalas, como niños o adultos mayores y pacientes que no hablen español o con otras barreras de comunicación (6).

Estrategia farmacológica

La estrategia farmacológica más utilizada para su tratamiento, aprobada por numerosas guías clínicas como la del NCCN, ESMO o SEOM, es la escalera analgésica de la OMS *(figura 6)* publicada en Cancer Pain Relief en 1986 y actualizada en 1996. La OMS recoge cómo se debe llevar a cabo la evaluación y el tratamiento del dolor en los pacientes con cáncer, basándose en una escala secuencial de tres niveles de fármacos que va desde fármacos con baja potencia hasta fármacos muy potentes, en función de la intensidad del dolor (2, 4, 6).

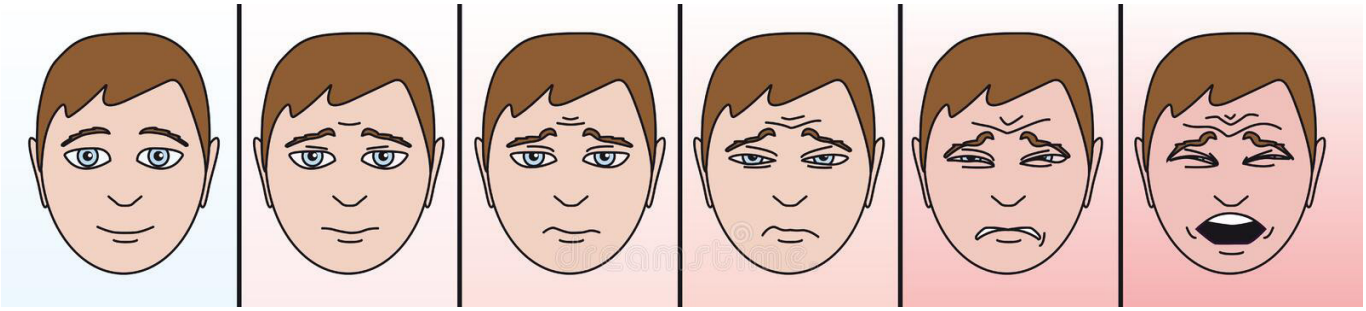

Figura 5. Escala de dolor con caras.

Dolor leve	Moderado	Severo
No opoides +/- coadyuvantes	Opoides débiles + no opoides +/- coadyuvantes	Opoides fuertes + no opoides +/- coadyuvantes

Figura 6. Escalera analgésica de la OMS.

Las metas en el manejo del dolor involucran lograr una disminución del dolor en un 30 al 50 % del inicial, prevención y tratamiento de los efectos adversos del tratamiento, maximizar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida del paciente (6). En realidad, para lograrlo, es necesario reconocer que el dolor es multidimensional y no sólo afecta la esfera física, también la sociológica, psicológica y cultural. Las personas con dolor sufren, así como su familia, cuidadores e incluso profesionales tratantes (6).

Paracetamol y AINE

En cuanto al tratamiento, la OMS recomienda iniciarlo con paracetamol y AINE. Aunque no hay estudios que indiquen la superioridad de uno frente a otro en el dolor oncológico, la guía de la EAPC recomienda el uso del paracetamol sobre los AINE, por su menor toxicidad gastrointestinal. La utilización de fármacos no opioides se recomienda en los tres niveles de la escalera en combinación con otros fármacos (2, 4, 6 – 10).

El paracetamol es un analgésico y antipirético que inhibe la síntesis de prostaglandinas únicamente a nivel central, por lo que no comparte todos los efectos adversos de los AINE a nivel periférico. No es lesivo al estómago, aunque sí tiene potencial de hepatotoxicidad, por lo que su dosis se limita a 4 gramos al día en pacientes que no ingieren alcohol ni otros medicamentos que tengan hepatotoxicidad. Dado que la prevalencia de ingerir alcohol es alta, se sugiere no pasar de 2.5 gramos al día (2, 4, 6 – 10).

El principal mecanismo de acción de los AINE es la inhibición de las ciclooxigenasas (COX) y, por tanto, de la producción de Prostaglandinas (PG), que se conoce como importantes en la sopa inflamatoria, por lo que son de gran importancia en el manejo del dolor agudo, perdiendo importancia en el dolor crónico (2, 4, 6 – 10).

Aun así, son muy socorridos y, al ser de venta libre, con mucha frecuencia se abusa de ellos y se cae en su mal uso al utilizar sobredosis, o bien al usar combinaciones de varios AINE, sin que esto incremente su potencia analgésica (2, 4, 6 – 10). La toxicidad más reportada es la gastrointestinal, estimándose entre el 10 % y el 60 % de quienes los toman. Entre un 2 % y un 40 % está reportado que presentan sangrado de tubo digestivo alto (STDA) o úlceras y perforaciones. Las lesiones de mucosa gástrica varían desde hiperemia hasta úlceras perforantes con STDA. Se reportan alrededor de 16,500 muertes al año en Estados Unidos relacionadas a STDA por AINE (2, 4, 6 – 10).

En un esfuerzo por disminuir estas complicaciones, se desarrollaron los inhibidores selectivos de COX-2. Se sabe que la COX-1 es constitutiva y la encargada de la síntesis de PG para funcionamiento normal del cuerpo: barrera mucosa gástrica, vasodilatación, agregación plaquetaria por tromboxanos. La COX-2, por su lado, es inducible cuando hay trauma o inflamación (2, 4, 6 – 10).

No contribuye a la formación de moco gástrico, pero si con cerca de la mitad de producción de PGI2 para función renal. Actualmente contamos con el celecoxib, etoricoxib y parecoxib (este último inyectable) y si han demostrado ser aproximadamente 10 veces más seguros a nivel gastrointestinal que los AINE no selectivos (2, 4, 6 – 10).

A nivel renal, los AINE inhiben las prostaglandinas (PGE2 y PGI2) aumentan el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular, la excreción de agua y sodio y estimulan la secreción de renina. Todas estas acciones se ven inhibidas por los AINE, siendo particularmente tóxicos cuando existe un insulto renal previo, como en pacientes diabéticos o hipertensos. Por esta razón debe de limitarse su ingesta en este grupo de población y de preferencia utilizar naproxeno o celecoxib, que son los que han demostrado ser menos agresivos. Por contraparte, evitar ketorolaco y etoricoxib (2, 4, 6 – 10).

Con respecto a la hepatotoxicidad, el patrón más común es daño hepatocelular, y las drogas más hepatotóxicas son diclofenaco y nimesulide (2, 4, 6 – 10). En síntesis, con respecto a los AINE, deben de utilizarse a la menor dosis posible, el menor tiempo posible y utilizar el menos tóxico posible acorde con las necesidades de inhibición de COX-1/COX-2. Se sugiere utilizarlos en dolor agudo y de tipo somático o visceral. No deben de usarse para manejo de dolor neuropático, ya que no son de utilidad (2, 4, 6 – 10).

Opioides

Si no se logra controlar el dolor, se debe pasar a un segundo escalón en el que se añade un opioide débil como codeína, dihidrocodeína y tramadol. El inconveniente es la frecuencia de efectos adversos como náuseas, vómitos o estreñimiento y que su eficacia está limitada a 3 - 4 semanas en la mayoría de pacientes. Debido a esto, algunos autores recomiendan la omisión del segundo escalón y el salto directo al tercero, empleando dosis bajas de morfina (2, 4, 6 – 10).

Su mecanismo de acción es interactuando con receptores endógenos, principalmente *mu, kappa y delta,* que son todos ellos receptores ligados a proteína Gi/o los cuales inhiben la adenilatociclasa y disminuyen la producción de AMPc, además promueven la apertura de canales de potasio y el cierre de canales de calcio presinápticos, todas estas acciones en conjunto disminuyen la excitabilidad neuronal. Estos receptores se encuentran principalmente en sistema nervioso central, pero también están a nivel periférico como en articulaciones y en tubo digestivo (2, 4, 6 – 10).

Clínicamente, se han clasificado en opioides débiles y fuertes. Esto con respecto a su potencia relativa sobre los receptores (2, 4, 6 – 10). Los opioides débiles más utilizados son tramadol, codeína y dextropropoxifeno; aunque al tramadol se le considera un opioide atípico por inhibir además la recaptura de serotonina (2, 4, 6 – 10).

La codeína tiene el inconveniente de que invariablemente viene con paracetamol o diclofenaco, lo que limita su titulación, y que depende su acción de la conversión endógena a morfina, ya que es una prodroga. El dextropropoxifeno solo ya es difícil de encontrar (2, 4, 6 – 10).

El tramadol, por su parte ofrece mucha versatilidad, ya que hay presentación en gotas, cápsulas, tabletas de liberación prolongada e inyectable. Se puede encontrar solo o combinado con paracetamol o algún AINE (2, 4, 6 – 10).

El tercer escalón engloba a los opioides potentes, a los que se recurre cuando el dolor es de intensidad moderada-severa y no es controlado con los fármacos anteriores. No tienen techo analgésico, por lo que, a mayor dosis, mayor efectividad (2, 4, 6 – 10).

Entre los opioides fuertes podemos contar con morfina, oxicodona, tapentadol, hidromorfona, hidrocodona, fentanil, buprenorfina y metadona. Existen en el mercado parches para aplicación transdérmica de buprenorfina y de fentanilo, que son de mucha utilidad cuando el tramadol no es suficiente, además de que resulta cómodo el aplicarlos cada 3 o 7 días dependiendo del caso, con lo que mejora el apego a tratamiento (2, 4, 6 – 10).

De morfina contamos con presentaciones en tabletas, ampolletas y de alta concentración para uso en bombas intratecales. Cabe mencionar que farmacológicamente la buprenorfina es un agonista parcial, pero a dosis clínicamente útiles se comporta como agonista puro. La nalbufina por su parte, es agonista sobre receptores *kappa* y antagonista sobre receptores *mu*, pero también aunque es igual de potente que la morfina, se prefiere evitar su uso. Solo hay inyectable (2, 4, 6 – 10).

El tapentadol es otro opioide atípico, ya que posee actividad intrínseca sobre receptores *mu* pero también es un inhibidor de la recaptura de noradrenalina, lo que hace que sea buena opción en pacientes con dolor somático y neuropático (2, 4, 6 – 10).

La metadona es quizás el más atípico de los opioides, ya que además de ser un potente agonista del receptor *mu*, es un antagonista del receptor NMDA. Lo que hace muy complejo su uso es que su farmacocinética no es lineal, ya que se une a los tejidos y su liberación es lenta, de tal forma que su vida media de eliminación es de 15 a 60 horas y tiene efectos acumulativos (2, 4, 6 – 10).

Además, su coeficiente de conversión a morfina es variable. Lo que limita mucho el uso de los opioides en dolor crónico son dos cosas: Sus efectos adversos y el estigma que tiene sobre mal uso y adicción (2, 4, 6 – 10).

Los efectos adversos más frecuentes son náusea y vómito, mareo, sedación, constipación, hipogonadismo y depresión respiratoria. La náusea y el vómito suelen autolimitarse al cabo de una semana de tratamiento, ya que se desarrolla tolerancia a este efecto con rapidez, pero en lo que ocurre es imperativo administrar un antiemético eficaz. Algo parecido ocurre con mareo y sedación, siendo dosis dependientes (2, 4, 6 – 10).

Con la constipación no se presenta tolerancia, por lo que el paciente debe mantenerse con manejo constante para estreñimiento, que va desde abundantes líquidos orales y fibra hasta laxantes de varios tipos. La depresión respiratoria es de particular cuidado en pacientes vírgenes a opioides y en los extremos de la vida, sugiriéndose iniciar con dosis bajas e ir incrementando paulatinamente (2, 4, 6 – 10).

La elección de uno u otro opioide se basa, fundamentalmente, en las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada uno, y en los efectos adversos que producen, eligiéndose el que mejor se adapte al paciente (2, 4, 6 – 10). En pacientes con compromiso severo de la función renal (tasa de filtrado glomerular < 30 mL/min) los opioides deben ser administrados con precaución. Los opioides de primera elección son el fentanyl o buprenorfina iniciando a bajas dosis y continuando con titulación cuidadosa (2, 4, 6 – 10).

Debido a la acumulación de metabolitos activos de la morfina, se debe disminuir la dosis y administrarse a intervalos más amplios, para disminuir el riesgo de eventos adversos. El fentanyl transdérmico es el opioide de elección en pacientes que han recibido opioides previamente (2, 4, 6 – 10). Todos los opioides son metabolizados por el hígado. Ante enfermedad hepática, su depuración disminuye y la biodisponibilidad y vida media de los opioides aumenta, así como la probabilidad de efectos adversos, secundario a altas concentraciones plasmáticas (2, 4, 6 – 10).

El metabolismo de la morfina y la metadona no se altera significativamente en enfermedad hepática, por lo que pueden usarse en estos pacientes. Adicionalmente se recomienda disminuir la dosis, disminuir la frecuencia de administración o evitar el uso de acetaminofén si el paciente tiene enfermedad hepática o historia de consumo moderado o pesado de alcohol (2, 4, 6 – 10). La vía transdérmica debe evitarse en estos pacientes, debido a que la absorción del medicamento puede ser variable e impredecible (2, 4, 6 – 10).

Rotación de los opioides

Ningún opioide es óptimo para todos los pacientes. Si no se logra un adecuado control del dolor, si se pierde la vía de administración o si los efectos adversos son significativos, se debe cambiar el opioide en una dosis equivalente, con el fin de alcanzar control del dolor con efectos adversos tolerables, esto es lo que se conoce como rotación (2, 4, 6). Es una estrategia útil para conseguir un equilibrio adecuado entre la analgesia y la toxicidad; debe realizarse de forma lenta y escalonada entre 7-10 días (2, 4, 6).

Para esto se deben tener en cuenta los radios de equianalgesia, para evitar la sobredosificación o subdosificación. Cuando un opioide es cambiado por analgesia insatisfactoria, efectos adversos intolerables, o ambos, la dosis de inicio debe ser menor a la dosis calculada (25 a 50 % de reducción) a partir de los radios equianalgésicos. En todos los casos, las dosis necesitan ser tituladas de acuerdo a la respuesta clínica. Cuando se cambie de morfina oral a subcutánea o intravenosa, la potencia analgésica relativa es de 2:1 y 3:1 *(tabla 1)* (2, 4, 6).

Un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios indica que la terapia con opioides de liberación prolongada o controlada (por ejemplo, morfina, codeína y oxicodona) proporciona un alivio eficaz del dolor durante períodos de evaluación que van de 1 a 9 semanas, (evidencia de categoría *A*1) (2, 4, 6).

Los ensayos controlados aleatorios indican que el tramadol proporciona un alivio eficaz del dolor durante períodos de evaluación que van de 4 a 6 semanas (evidencia de categoría *A*2). Los estudios con hallazgos observacionales informan que los opioides de liberación inmediata, los opioides transdérmicos y los opioides sublinguales brindan alivio para el dolor durante períodos de evaluación que varían de 2 semanas a 3 meses (evidencia de categoría *B*2) (2, 4, 6).

Los mareos, la somnolencia y el prurito se encuentran entre los efectos secundarios notificados asociados con la terapia con opioides (evidencia de categoría *B*2) (2, 4, 6) *(Tabla 2).*

Potencia analgésica relativa	
Morfina oral a oxicodona	2:1
Morfina oral a hidromorfona	5:1
Morfina oral a metadona	10:1
Morfina oral a buprenorfina TD	75:1
Morfina oral a fentanyl TD	150:1

Tabla 1. Potencia analgésica relativa.

Fármaco	Vía administración	Forma farmacéutica
Morfina	Oral	• Compromidos (Sevredol®) • Comprimidos liberación prolongada (MST continus®)
	SC, IV, IM, intratecal, epidural	Solución oral (Oramorph®)
Hidromorfona	Oral	Comrpimidos liberación prolongada (Palladone Continus®)
Oxicedona	Oral	• Cápsulas duras (Oxunorm®) • Comprimidos liberación prolongada (Oxyconttin®) • Solución oral (Oxynorm®)
	SC, IV	Solución inyectable (Oxynorm®)
Fentanilo	Transmucosa oral	• Comprimidos bucales (Effentora®) • Comprimidos sublinguales (Abstral®) • Compromidos para chupar con aplicador (Actiq®) • Película bucal (Breakul®)
	Nasal	Solución para pulverización nasal (Percfent®, Instanyl®)
	IV, IM	Solución inyectable (Fentanest®)
	Transdémica	Parches transdérmicos (Darogesic Matriz®)
Metadona1	Oral	• Comprimidos (Netasedin ® 5mg) • Solución oral (Eptadone® 20 mg (1m/ml)
	SC	Solución inyectable (Metasedin®)
Buprenorfina	Sublingual	Comprimidos sublinguales (Buprex®)
	Transdérmica	Parches transdérmicos (Feliben®)
	IV, IM	Solución inyectable (Buprex®)
Tapentadol	Oral	• Comprimidos (Palexia®, Yantil®) • Comprimidos de liberación prolongada (Palexia retard®, Yantil retard®)

Tabla 2. Fármacos opioides más utilizados.

Adyuvantes

Para mejorar la eficacia del tratamiento y reducir las dosis de opioides, la OMS recomienda la adición de fármacos adyuvantes en cualquier nivel de la escalera. Estos fármacos, pese a que no son analgésicos, ayudan a controlar el dolor (2, 4, 6 – 10). Los analgésicos coadyuvantes son compuestos que tienen una baja potencia analgésica. Sin embargo, la sinergia con opioides incrementa su efecto y favorece una reducción en los eventos adversos de los narcóticos para el control del dolor (2, 4, 6 – 10).

Las estrategias ahorradoras de opioides están relacionadas con el efecto de una variedad de receptores, de los cuales podemos nombrar: los antagonistas NMDA como la ketamina, magnesio y dextrometorfano, los agonistas α-2 como la clonidina y la dexmedetomidina, los inhibidores de la subunidad α-2δ de los canales de calcio como la pregabalina y la gabapentina, los bloqueadores de los canales de sodio como la lidocaína y, finalmente, los glucocorticoides (2, 4, 6 – 10).

Los metaanálisis de ensayos controlados aleatorios informan que los antagonistas de los canales de calcio -2-delta proporcionan un alivio del dolor neuropático eficaz durante períodos de evaluación que van de 5 a 12 semanas (evidencia de categoría *A*1) (2, 4, 6 – 10).

Además, un metanálisis encontró que los antagonistas de los canales de sodio o los anticonvulsivos estabilizadores de la membrana proporcionan un alivio eficaz del dolor durante períodos de evaluación que van de 2 a 18 semanas (evidencia de categoría *A*1) (2, 4, 6 – 10).

Los consultores, miembros de ASA y miembros de ASRA están totalmente de acuerdo en que los antagonistas de los canales de calcio 2-delta, los bloqueadores de los canales de sodio y los fármacos estabilizadores de membranas deben usarse en pacientes con dolor neuropático (2, 4, 6 – 10).

Los datos de observación de estudios indican que los antagonistas del receptor NMDA proporcionan alivio del dolor neuropático durante períodos de evaluación que van de 2 a 16 semanas (evidencia de categoría *B*2) (2, 4, 6 – 10). Los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están de acuerdo en que los antagonistas del receptor de NMDA deben usarse para el dolor neuropático (2, 4, 6 – 10).

Tratamiento de tipos específicos de dolor

Dolor neuropático

El dolor neuropático es frecuente en los pacientes con cáncer y es de difícil manejo, puede ser causado por infiltración tumoral, síndrome paraneoplásico o secundario a polineuropatía inducida por el tratamiento. Puede tratarse con analgésicos opioides, no opioides y antidepresivos tricíclicos o anticonvulsivantes (4, 6).

La eficacia y tolerabilidad de la terapia debe ser monitorizada en el tiempo y en caso de compresión nerviosa pueden usarse esteroides (4, 6).

Los antidepresivos más eficaces son los IRSN y ATC, entre los que destacan la duloxetina, venlafaxina y amitriptilina. Los anticonvulsivantes de elección son gabapentina y pregabalina, dado que producen menos efectos adversos e interacciones farmacológicas. Por último, los anestésicos locales como la lidocaína también han demostrado eficacia en el alivio de este dolor (4, 6).

No obstante, el dolor oncológico suele ser mixto, con componente nociceptivo y neuropático, por lo que la terapia en este caso debe basarse en la combinación de opioides con antidepresivos y anticonvulsivantes (4, 6).

Dolor en metástasis óseas

El síntoma más preocupante en los pacientes con metástasis óseas es el dolor óseo. Para su tratamiento, se dispone de diversas alternativas. La administración de AINE, opioides y especialmente, corticoides por su potente acción antiinflamatoria, ha demostrado eficacia en el alivio del dolor (4, 6).

La radioterapia consigue aliviar el dolor en el 70 % de los casos, incluso tras una sola sesión. Además, previene la aparición de fracturas, frena el crecimiento tumoral local y disminuye el consumo de analgésicos (4, 6).

Si los analgésicos o la radioterapia resultan ineficaces, se recomienda combinarlos con bifosfonatos como el ácido zolendroico o el pamidronato. Estos fármacos inhiben la resorción ósea y la actividad de los osteoclastos, con lo que reducen el riesgo de sufrir eventos óseos. En consecuencia, además de aliviar el dolor, reducen el riesgo de fracturas (4, 6).

Dolor oncológico irruptivo

El objetivo de su tratamiento es reducir la intensidad de los episodios, utilizando para ello principalmente fármacos opioides. Las guías clínicas recomiendan la combinación de opioides de liberación convencional o prolongada para controlar el dolor basal, con dosis de rescate de opioides de liberación rápida para las crisis y el uso del mismo principio activo en ambos casos (4, 6).

Una de ellas, el rápido inicio de la analgesia, es el motivo por el cual el tratamiento tradicional con morfina u oxicodona de liberación inmediata ha dejado de prescribirse, al tardar más de 30 minutos en aliviar el dolor. Se ha sustituido por otros opioides como el fentanilo, que comparte las características del fármaco ideal y del que se dispone de una amplia variedad de formas farmacéuticas (4, 6).

Conclusiones

Es importante evaluar el dolor oncológico según intensidad y tipo según fisiopatología, pues evaluación adecuada es terapéutica adecuada. Dentro de las herramientas farmacológicas, se proponen una variedad de fármacos tales como el metimazol, el paracetamol; coadyuvantes analgésicos como los anticonvulsivantes; antidepresivos y bifosfonatos, usados en asociación a los analgésicos en caso de predominar el componente neuropático.

Medicamentos como los corticoides se usan gracias a su acción antiinflamatoria, indicándose en especial para el dolor oncológico debido a metástasis óseas, hipertensión intracraneal, tumores de cara o cuello, compresión medular o nerviosa y hepatomegalia; pero el pilar de manejo del dolor oncológico lo encabezan los opioides.

Bibliografía

1. Forero M, Cardona A. Historia del cáncer y el cáncer en la historia. Medicina (Mex). el 15 de febrero de 2021;42:528–62.
2. Juvier Y, Ortega Y, Rodríguez L, Cuevas O, Ruiz D. Tratamiento del dolor en el paciente oncológico Treatment of pain in oncological patients. 2019;10.
3. Camino N. Manejo y abordaje del dolor en pacientes oncológicos desde una perspectiva de género. Revisión sistemática. 2020. Recuperado a partir de: https://uvadoc.uva.es/handle/10324/41918
4. Marrero L. Manejo del dolor oncológico. 2019. Recuperado a partir de: https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/15982
5. Pastor A, Amorós A, Valero R. Rotación a Metadona en domicilio como alternativa en dolor refractario oncológico. Hosp Domic [Internet]. el 31 de octubre de 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021];3(4):279–88. Recuperado a partir de: https://www.revistahad.eu/index.php/revistahad/article/view/81
6. León M, Santa J, Martínez S, Ibatá L. Recomendaciones basadas en evidencia para el manejo del dolor oncológico (revisión de la literatura). Rev Mex Anestesiol [Internet]. el 30 de enero de 2019. Recuperado a partir de: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=84793
7. Noe C. Pain management for clinicians a guide to assessment and treatment [Internet]. Cham: Springer; 2020. Recuperado a partir de: http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6207793
8. Coutaux A. El dolor y su tratamiento en adultos. EMC - Tratado Med [Internet]. el 1 de febrero de 2019. Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S163654101841700X
9. Alcántara A, Ibor P, Alonso A, Trillo E. Actualización en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Med Fam SEMERGEN [Internet]. el 1 de noviembre de 2019. Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138359319302060
10. Alcántara A, Sánchez C. Papel de los bloqueadores de los canales de sodio dependientes de voltaje en el tratamiento del dolor crónico: usos potenciales en la práctica clínica según la evidencia disponible. Rev Esp Anestesiol Reanim [Internet]. el 1 de mayo de 2018. Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034935618300161